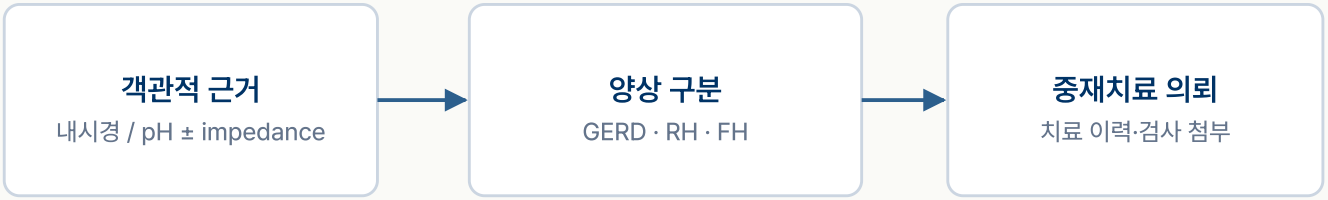
역류 중재치료 의뢰 전 확인사항

수술·내시경 중재를 검토할 때는 actionable GERD를 뒷받침하는 객관적 자료를 모은다.

핵심 판단 한눈에



내시경과 역류 모니터링으로 GERD 근거를 확인한 뒤 중재치료를 의뢰한다.

의뢰 자료 · 내시경과 역류 모니터링

자료	강의에서 확인하는 항목
내시경	LA grade, Barrett 식도, 소화성 협착, hiatal hernia
24시간 pH ± impedance	산 노출시간(AET), 총 역류횟수, 평균 야간 기저 임피던스(MNBI)
Lyon 2.0 강의 표	LA-B/C/D·Barrett·협착, AET >6%: 확정 근거 / LA-A·AET 4–6%·역류 40–80회/일: 경계
보조·반대 근거	>80회/일·MNBI <1,500Ω: 보조 / AET <4%·<40회/일·MNBI >2,500Ω: 반대 근거

수치 해석과 치료 이력

강의의 지역 기준 설명

연자는 아시아·Seoul Consensus의 AET 4% 이상 기준을 별도로 설명했다. 증상만으로 확정하지 않고, 약제·용량·반응과 객관적 검사 결과를 함께 전달한다.

강의에서 소개한 내시경 중재

방식	소개된 작용
Stretta (radiofrequency)	하부식도괄약근 압력 증강
TIF (EsophyX·MUSE·GERD-X)	하부식도괄약근 재구성
ARMS·ARMA·ARMS-C	분문부 수축 (cardia constriction)

의뢰 체크

- [ ] 역류 과민성·기능성 가슴쓰림과 구분한 자료를 첨부한다.
- [ ] 내시경·산도검사 결과와 치료 반응을 전문기관에 전달한다.